文章编号:1005-0957(2024)10-1160-05

·经络腧穴·

悬钟穴定位及经属之源流考辨

王宇[1],李艳梅[2],陈少宗[1]
(1.山东中医药大学,济南 250014;2.山东省中医药研究院,济南 250013)

【摘要】 悬钟穴作为临床常用穴之一,长期以来针灸学界将其与绝骨等同,并归入足少阳胆经。该文通过查阅古今主要针灸文献中悬钟的定位和主治,分析其源头与演变,并阐述悬钟穴正确定位及主治,认为现代针灸学中的悬钟与古籍所载“悬钟”出现名实分离现象,且古之悬钟和绝骨并非一穴,古之悬钟定位在小腿前侧,外踝尖上3寸,胫骨前嵴外侧,胫前动脉搏动处,主治足阳明经胃腑类疾病,同时结合悬钟定位主治推测本穴应归属于足阳明胃经。

【关键词】 穴,悬钟;经络;足少阳胆经;腧穴;综述;穴位考证
【中图分类号】 R245　【文献标志码】 A
DOI:10.13460/j.issn.1005-0957.2024.10.1160

自《备急千金要方》首次将悬钟穴与绝骨穴等同后,历代针灸医籍及近代各版本《针灸学》教材均沿用此观点,通过查阅文献,笔者发现此观点不符合《黄帝明堂经》所载“悬钟”本意,即悬钟与绝骨实为二穴,且“悬钟穴”定位、主治出现名实分离现象。有关悬钟和绝骨穴的文献探讨,各家观点不一,但都认为悬钟穴归属足少阳胆经,偏重探讨悬钟穴与骨性标志之位置关系。李志道教授[1]认为悬钟穴位于腓骨前缘,且与绝骨、髓会为3个不同概念。睢明河教授团队[2]对建国后悬钟穴定位记载进行梳理,认为悬钟穴位于胫骨前嵴和腓骨前缘之间。笔者基于悬钟穴的古今文献,以《黄帝明堂经》原文记载的脉动标志(阳明脉)为线索,对其源流进行考辨,并提出自己的观点,以供同道斧正。

1　从古代文献探讨悬钟穴定位问题

悬钟首见于西汉末年成书的《黄帝明堂经》[3],原书散佚,其内容多被收录于《针灸甲乙经》,原文提及悬钟穴定位“悬钟,在足外踝上3寸动者中,足三阳络,按之阳明脉绝乃取之”,即悬钟穴的定位方法描述为骨度分寸法结合脉动标志,悬钟穴在外踝尖上3寸水平线上,胫前动脉搏动处,重按该穴则下方足阳明经跗阳脉(足背动脉)处搏动消失[4]。因此笔者认为悬钟穴以阳明脉动定位符合《黄帝明堂经》之本意。

那么悬钟穴是如何从“足外踝上3寸动者中,足三阳络,按之阳明脉绝”演变到与绝骨穴重合的呢?从以下图表中,可以看出悬钟穴定位演变源流之概况及与绝骨穴相混淆并成为一穴的脉络。详见表1。

从历史沿革来看,《黄帝内经》至唐代(652年)间,悬钟穴定位方法基本与《黄帝明堂经》一致,在足外踝上3寸动者中,足三阳络,按之阳明脉绝乃取之。“动者”指胫前动脉的搏动;“阳明脉”指“足背动脉”[4];“绝”《说文解字》中“断丝也”,即中断、不连贯之意。悬钟穴在足外踝上3寸水平线上,胫前动脉搏动处,按压此处,下方足背动脉搏动会减弱甚至中断。胫前动脉循行于小腿前外侧肌肉深部,需深按方可触及,其向下移行为足背动脉,搏动可于浅表处扪及,古人巧用按压上方胫前动脉使“足背动脉”搏动减弱或消失的解剖特点,以验证悬钟取穴正确与否。唐以前悬钟穴以“阳明脉动”为取穴标志,孙思邈《备急千金要方》中首次提出“悬钟、绝骨为同一穴位”后,二者定位开始发生重叠,此后,悬钟的取穴定位方式产生变动,

基金项目:山东省自然科学基金重大基础研究项目(ZR2020ZD17)
作者简介:王宇(1998—),女,2021级硕士生,Email:554162166@qq.com
通信作者:李艳梅(1969—),女,教授,Email:zutzhangpz@sina.com

表 1 关于悬钟和绝骨穴定位的古代主要针灸文献

时间	著作	悬钟穴定位	绝骨穴定位
	黄帝内经[5-6]		1.穴位:骭酸痛甚,……,以镵针,针绝骨出血。 2.骨性标志:阳辅,外踝之上,辅骨之前,及绝骨之端也。
公元 106 年(西汉)	黄帝明堂经[1]	在足外踝上 3 寸动者中,足三阳络,按之阳明脉绝乃取之。	骨性标志:阳辅者,……,辅骨前,绝骨端。
公元 652 年(唐)	备急千金要方[7]	悬钟,一名绝骨,在外踝上 3 寸动者中,足三阳络。	1.穴位:绝骨穴,脚外踝上一夫,亦云四寸是。 2.骨性标志:阳辅,……,绝骨端三分。 3.悬钟别称。
公元 1026 年(北宋)	铜人腧穴针灸图经[8]	悬钟二穴,在足外踝上 3 寸,动脉中,足三阳之大络,按之阳明络绝乃取之。	骨性标志:阳辅二穴,在足外踝上 4 寸,辅骨,绝骨端如前三分,去丘墟 7 寸。
公元 1601 年(明)	针灸大成[9]	足外踝上 3 寸动脉中,寻摸尖骨者是。足三阳之大络。按之阳明络绝,乃取之。	1.穴位:骭酸痛甚,……,以镵针,针绝骨出血。 2.骨性标志:阳辅,足外踝上四寸,辅骨前,绝骨端三分。 3.悬钟别称。
公元 1742 年(清)	医宗金鉴[10]	从阳辅下行 3 寸,外踝骨尖内动脉中,寻按取之。	骨性标志:辅骨前绝骨端,内斜三分,阳辅也。

出现“脉动”“骨性标志”混用情况,如《针灸大成》对悬钟取穴方式同时出现“动脉中”与“寻摸尖骨”。

绝骨穴历代医家定位如何?笔者查阅古代文献发现绝骨首见于《素问·刺疟》中“骭酸痛甚,按之不可,名曰胕髓病。以镵针,针绝骨出血,立已”[5]。此处仅提及绝骨穴是足少阳胆经一经穴(一说阳辅穴)[11],未提及具体定位。《灵枢·本输》中,绝骨作为体表骨性标志出现,“阳辅,外踝之上,辅骨之前,及绝骨之端也”[4]。此处“绝骨”指外踝上直上 3 寸许腓骨的凹陷处[12],即在唐《千金方》之前,“绝骨”就有穴位以及体表骨性标志 2 种含义,但均与悬钟以“阳明脉动”定位无关。652 年《备急千金要方》首次提出“绝骨等同悬钟,然本书同时出现“绝骨穴,在脚外踝上一夫,亦云四寸是”这种矛盾的表述。

在查阅古籍过程中,笔者发现除悬钟和绝骨穴相混淆外,绝骨与阳辅穴之间亦有混淆,并间接导致悬钟和绝骨穴定位模糊,如北宋《铜人腧穴针灸图经》首提“阳辅二穴,在足外踝上 4 寸,辅骨前,绝骨端如前三分,去丘墟 7 寸”,阳辅“外踝上 4 寸”与“去丘墟 7 寸”表述矛盾。清《医宗金鉴》中亦出现阳辅和悬钟穴定位矛盾的问题。对此,黄龙祥教授通过对历代古籍中足少阳经腿部穴排序进行详细考证,认为阳辅穴位于“外踝上 7 寸”水平线上,阳辅、绝骨和悬钟穴为 3 个不同穴位,符合《黄帝明堂经》本意[13]。

由上可以总结出以下两点。第一,唐《千金要方》时期绝骨仍有多重含义,外踝上某穴位(或为阳辅穴)、骨性标志、悬钟穴别称。第二,唐《千金要方》时期,悬钟穴概念始与绝骨重合,虽然悬钟和绝骨穴二者定位及取穴方式并不相同,诸家著作及后世教科书均遵《千金要方》观点,悬钟穴即绝骨穴,悬钟穴的取穴方式由“脉动”变为“脉动”及“骨性标志”混用,出现定位模糊情况,为临床规范取穴带来困难。

从穴位命名角度来看,“悬”通“县”。《说文解字》:“系也。”据考证,悬钟在足外踝上 3 寸,可能因旧时有小儿常在此处悬系铃铛,铃响声似钟而得名[14]。此处仅提及“悬钟”位于足外踝上 3 寸,未提及具体取穴方式。“绝骨”其命名方式即表明该穴以“骨性标志”定位,考其《内经》中本意为由外踝向上寻按,至腓骨不能被触及的凹陷处[12],由此仅可知悬钟和绝骨二穴皆在小腿外侧、足外踝上某处,无充分证据支持二者同为一穴。

从解剖关系来看,《千金要方》中绝骨穴“在脚外踝上一夫,亦云四寸是”,其取穴参照骨性标志为外踝,即腓骨下端一窄长隆起,腓骨外侧肌群为腓骨长肌及

腓骨短肌[15]。绝骨穴取“外踝上腓骨不能触及的凹陷”实为腓骨与腓骨长短肌交界处，现代学者进行实际人体测量发现外踝至此凹陷均值为 3.83 寸[16]。悬钟穴定位之脉动为“胫前动脉”，其上 1/3 段穿行于胫骨前肌和趾长伸肌之间，下 2/3 段位于胫骨前肌与拇长伸肌间[17]。胫前动脉循行肌肉并无腓骨外侧肌群，即在足外踝上 3 寸水平线上，无法同时满足“按之阳明脉绝”与“腓骨不能触及之凹陷”两点。因此，将“外踝上”之绝骨穴与“胫前动脉”搏动处之悬钟穴等同有疑。

尽管自唐《千金方》将悬钟绝骨等同后，悬钟定位描述开始出现骨性标志，其本源定位方式皆为脉动结合骨度分寸。而古文献中关于绝骨定位描述仅有骨性标志，在外踝上 3 寸水平线上，悬钟取穴无法同时找到“胫前动脉搏动”与“不能触及腓骨的凹陷”两处，由此可知，悬钟绝骨实为两穴，但二者同在小腿外侧外踝上某处。

2　从古代文献探讨悬钟穴经属问题

自《黄帝明堂经》始，悬钟穴皆归于足少阳胆经，然而在查阅历代文献，比对悬钟穴取穴方式与主治后，笔者认为悬钟穴归入足阳明胃经较为合理。

从气血流注角度来看，足阳明胃经“其支者，起于胃口，……，下入膝髌中，下循胫外廉，下足跗”，即足阳明胃经一支脉下入膝盖髌骨中央，在小腿部沿胫骨外侧下行至足背[18]。《素问·针解》[11]言足三里“在膝下三寸，胕外两筋肉分间。极重按之，则足跗上动脉止矣”。此处足跗上动脉为足背动脉，亦是足阳明胃经原穴冲阳穴所在。《针灸甲乙经》言冲阳“足阳明脉之所过也，为原”。原穴冲阳穴，是足阳明胃经原气经过和留止的部位。现代解剖发现，足三里穴深部动脉为胫前动脉[19]，穿行于髌骨外下方较厚的胫骨前肌并向下移行为足背动脉，因足三里穴处一般难以触及脉动，可通过深按足三里穴处动脉，观察下方浅表足背动脉搏动变化，进而得出足三里和冲阳二穴处于同一条动脉的体表投影线。又因为足三里和冲阳穴同属足阳明胃经，可知胫前动脉是足阳明胃经膝关节以下小腿部气血流注的通道。同理，悬钟穴的取穴方式也是通过按压悬钟旁的胫前动脉，使下方足背动脉搏动减弱或消失。尽管近代针灸界对经络实质相关研究结论认为，经络不能完全等同于血管，经络循行也不完全等同于血管循行[20]，但是在小腿部，从胫前动脉循行部位角度，胫前动脉及移行的足背动脉与足阳明胃经有高度相似性。从《黄帝明堂经》中足三里、悬钟和冲阳穴的定位方式来看，三者均以趺阳脉减弱或消失为定位方法，同时结合冲阳穴为足阳明胃经原穴的特性，可以得出，从经脉循行角度，足三里、悬钟和冲阳穴为一脉相承，皆位于足阳明胃经气血灌注通道上。因此，悬钟位于足阳明胃经循行线上更妥。

从主治角度来看（详见表 2），唐代以前，悬钟和绝骨穴主治并不相同，悬钟穴主治胃腑类疾病，绝骨穴主治腰腿疼痛等骨性疾病。自唐《备急千金要方》将悬钟和绝骨二穴等同后，至清代《医宗金鉴》时期，悬钟穴主治范围扩大，在胃腑病基础上逐渐增加绝骨的腰腿疼痛类骨性疾病，但从主治记载顺序来看，悬钟穴主治仍首推胃腑类疾病，说明直至清代，悬钟穴主治胃腑类疾病得到临床广泛应用，该观点符合《黄帝明堂经》本意。结合悬钟穴取穴方式与同在下肢的足阳明胃经经穴相同，且悬钟气血流注于足阳明胃经上，笔者推测悬钟穴本为足阳明胃经经穴。同时，在小腿部，足阳明胃经“下循胫外廉”，悬钟穴的取穴方式可以进一步明确为外踝尖上 3 寸胫骨前嵴外，胫前动脉搏动处，深按可使足背动脉搏动减弱或消失。

明确该穴定位及归经的意义主要有以下两点。首先，明确悬钟穴定位有助于正确认识并指导该穴取穴及临床应用。从古今对于悬钟定位记载文献来看，其定位存在模糊不定之状。自唐《千金方》将悬钟和绝骨穴等同后，受绝骨以“骨性标志”定位影响，悬钟穴定位在历代文献中几经变化，在外踝上 3 寸水平线上，悬钟穴取穴方式由“脉动”到“脉动结合骨性标志”（详见表 1），至 1962 年《针灸学》[21]收录《甲乙经》中悬钟穴以“脉动”定位的原文，却在取穴方法时采用骨性标志这种自相矛盾的描述，此后教材几易[22-24]，悬钟穴定位与腓骨前后缘关系亦几经改动，始终未阐释明确，笔者猜测此腓骨前后缘之争恰是针灸学界苦于悬钟和绝骨二穴概念混淆造成，现今悬钟穴定位腓骨前缘是学界在古“悬钟”以胫前动脉定位与“绝骨”以腓骨定位的折中之法，其根源在于尚未厘清二穴源头，辨明二穴本质。各版本教材对于悬钟穴定位描述不尽相同，取穴方式芜杂，在临床实践中不易正确取穴，与《黄帝明堂经》中悬钟原本取穴方法相去甚远，并直接导致悬钟穴临床主治与本意产生较大偏离。通过对悬钟定位方式进行古代文献梳理，明晰悬钟原本定位及取穴方

式,使悬钟临床取穴方法规范化、准确化,进而提高其临床应用价值。其次,明确悬钟穴的经属,对临床治疗疾病病种具有指导意义。《黄帝明堂经》悬钟本意为治疗阳明经胃腑类疾病,唐代悬钟绝骨二穴等同后,悬钟定位及主治更多偏向绝骨,且受“髓会绝骨”影响,建国后教材对其主治病种的记载几经变动,近二十年以治疗肢体病变和髓海疾病为主[25-27],现今临床多应用于髓海不足,腰腿疼痛类疾病,原本胃腑类主治较少人应用。对悬钟进行文献整理可端本正源,追溯古文献中悬钟穴原本面目,对当今腧穴规范化做些许工作,亦对悬钟穴临床治疗胃腑类疾病提供理论依据。

表 2 关于悬钟绝骨主治的古代主要针灸文献

时间	著作	悬钟穴主治	绝骨穴主治
公元 106 年(西汉)	黄帝明堂经[3]	1. 胃腑疾病:主腹满,胃中有热,不嗜食。小儿腹满不能食饮。	1. 腰腿疼痛疾病:主身懈,寒少气,热甚恶人,心惕惕然,取光明及绝骨。
公元 256 年(晋)	针灸甲乙经[4]	1. 胃腑疾病:主腹满,胃中有热,不嗜食。小儿腹满不能食饮。	1. 腰腿疼痛疾病:胫酸痛,……,以镵针针绝骨出其血,立已。
公元 652 年(唐)	备急千金要方[7]	1. 胃腑疾病:主腹满。主小儿腹满,不能食饮。 2. 二阴病:主五淋。 3. 腰腿疼痛疾病:主湿痹流肿,髀筋急瘛,胫痛。	1. 脚气病:凡脚气,……,一说灸绝骨最要。 2. 心烦、足胫疼:绝骨,……,治风、身重、心烦、足胫疼。 3. 逆气虚劳,寒损忧恚等疾病:逆气虚劳,寒损忧恚,……,凡二十二病,皆灸绝骨五十壮。 4. 胃腑疾病:绝骨主病热欲呕。 5. 肢体痿痹疾病:……绝骨、前谷主四肢不举。 6. 风病:绝骨主风劳身重。
公元 992 年(北宋)	太平圣惠方[28]	1. 胃腑疾病:主心腹胀满。胃中热。不嗜食。 2. 腰腿疼痛疾病:膝胫连腰痛。腿胯连膝胫痹麻。屈伸难也。	1. 肝胆系疾病:黑黄者,烙百会穴,……,绝骨二穴;脊禁黄者,烙百会,……,绝骨二穴;髓黄者,烙下廉二穴,……,绝骨二穴。 2. 中风:此乃将中风之候也。便须急灸三里穴与绝骨穴。
公元 1601 年(明)	针灸大成[9]	1. 胃腑疾病:主心腹胀满,胃中热,不嗜食。 2. 腰腿疼痛疾病:脚气,膝胕痛,筋骨挛痛足不收。 3. 逆气,虚劳寒损等疾病:逆气,虚劳寒损,……,烦满狂易。 4. 髓海不足疾病:中风手足不随。	同悬钟
公元 1742 年(清)	医宗金鉴[10]	1. 胃腑疾病:悬钟主治胃热,腹胀。 2. 肝胆系疾病:肋痛。 3. 脚气,脚胫湿痹等疾病:脚胫湿痹,浑身瘙痒,趾疼等症。	

3 小结

综上,笔者认为悬钟穴与绝骨穴实为两穴,悬钟穴定位及取穴方法为外踝尖上 3 寸,胫骨前嵴外侧,胫前动脉搏动处取穴,深按可使足背动脉搏动减弱或消失。

通过考辨古今文献中悬钟穴定位方法及主治，得出悬钟穴应归属于足阳明胃经，主治以胃腑类疾病为主。

参考文献

[1] 田苑，李婷，时旭平，等. 李志道悬钟穴研究撷粹[J]. 江苏中医药，2015(5)：68-69.

[2] 刘佳男，唐雪青，何晓茜，等. 关于悬钟穴定位的探讨[J]. 针刺研究，2021(1)：73-75.

[3] 黄龙祥. 黄帝明堂经辑校[M]. 北京：中国医药科技出版社，1987：219，220，241.

[4] 山东中医学院. 针灸甲乙经校释[M]. 北京：人民卫生出版社，2009：373，790.

[5] 山东中医学院，河北医学院. 黄帝内经素问校释[M]. 北京：人民卫生出版社，1982：390-391.

[6] 灵枢经[M]. 北京：人民卫生出版社，2012：6.

[7] 孙思邈. 备急千金要方[M]. 北京：中医古籍出版社，1999：239，273，565，901，902，928，931，934，942-944，959.

[8] 王惟一. 新刊补注铜人腧穴针灸图经校注[M]. 郑州：河南科学技术出版社，2015：36，230.

[9] 张缙. 针灸大成校释[M]. 北京：人民卫生出版社，1984：735，736.

[10] 吴谦. 医宗金鉴[M]. 北京：人民卫生出版社，2006：1856-1857，1905.

[11] 王冰. 重广补注黄帝内经素问[M]. 北京：中医古籍出版社，2015：182，247.

[12] 张登本. 内经词典[M]. 北京：人民卫生出版社，1990：406.

[13] 黄龙祥，黄幼民. 针灸腧穴通考—《中华针灸穴典》研究[M]. 北京：人民卫生出版社，2011：1103-1104.

[14] 刘冠军. 腧穴命名汇解(续八)[J]. 陕西新医药，1977(5)：63-65.

[15] 邵水金. 人体解剖学[M]. 北京：中国中医药出版社，2016：54，69.

[16] 张载义. 也谈绝骨穴部位[J]. 南京中医学院学报，1989(4)：46.

[17] 崔慧先，李瑞锡. 局部解剖学[M]. 北京：人民卫生出版社，2018：263.

[18] 河北医学院. 灵枢经校释[M]. 2 版. 北京：人民卫生出社，2009：182-186.

[19] 梁繁荣. 针灸学[M]. 北京：中国医药科技出版社，2021：45.

[20] 周磊，唐昌建. 关于人体经络实质认识与研究方法的探讨[J]. 中国医学物理学志，2006(3)：188-193.

[21] 上海中医学院. 针灸学第 2 册[M]. 北京：人民卫生出版社，1962：332.

[22] 南京中医学院. 针灸学讲义[M]. 上海：上海科学技术出版社，1964：164.

[23] 杨甲三. 针灸学[M]. 北京：人民卫生出版社，1989：328.

[24] 国家技术监督局. 经穴部位：GB12346—90[S]. 北京：中国标准出版社，1990：18.

[25] 石学敏. 针灸学[M]. 北京：中国中医药出版社，2002：98.

[26] 沈雪勇. 经络腧穴学[M]. 北京：中国中医药出版社，2021：153.

[27] 梁繁荣. 针灸学[M]. 北京：中国中医药出版社，2021：92.

[28] 王怀隐. 太平圣惠方校点本[M]. 北京：人民卫生出版社，2016：1163-1165，2234-2235，2244.

收稿日期2024-01-07